

Diagnostics d'Exclusion : Pathologies Sévères

Cancer colorectal (2ème cause de décès, souvent sigmoïde)

Rectocolite hémorragique (RCH)
(Inflammation muqueuse, risque de cancérisation)

Iléus mécanique (Obstruction, hyperpéristaltisme, météorisme)

Diverticulite / Sigmoidite

Polypes colorectaux

 **Rectorragies & Méléna** (sang noir digéré)

 **Fièvre & Amaigrissement / Anémie**

 **Alternance inhabituelle de constipation et de diarrhée**

 **Écoulement de liquides troubles par voie anale**

 **Douleur abdominale forte & Altération de l'état général**

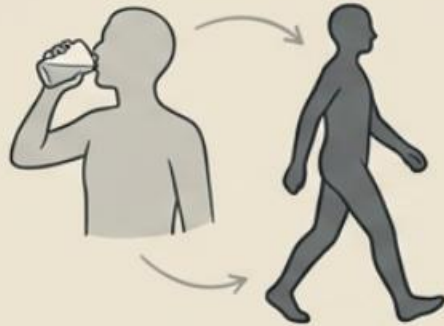
Pathologies Organiques Sévères



Matrice du Mode de Vie : L'Équilibre du Transit

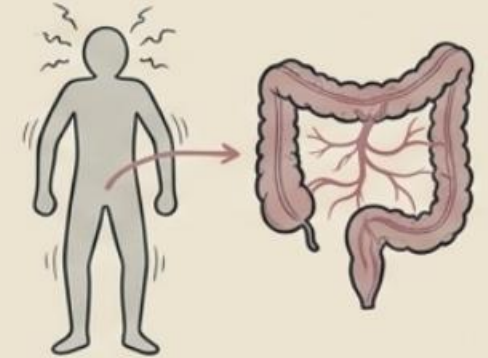
Hydratation & Mouvement

Fondamentaux : Un apport hydrique insuffisant et un manque d'activité physique entretiennent la constipation.



Stress

Le stress chronique inhibe l'activité neuro-végétative du péristaltisme.



Aliments Constipants

Chocolat, banane, riz.

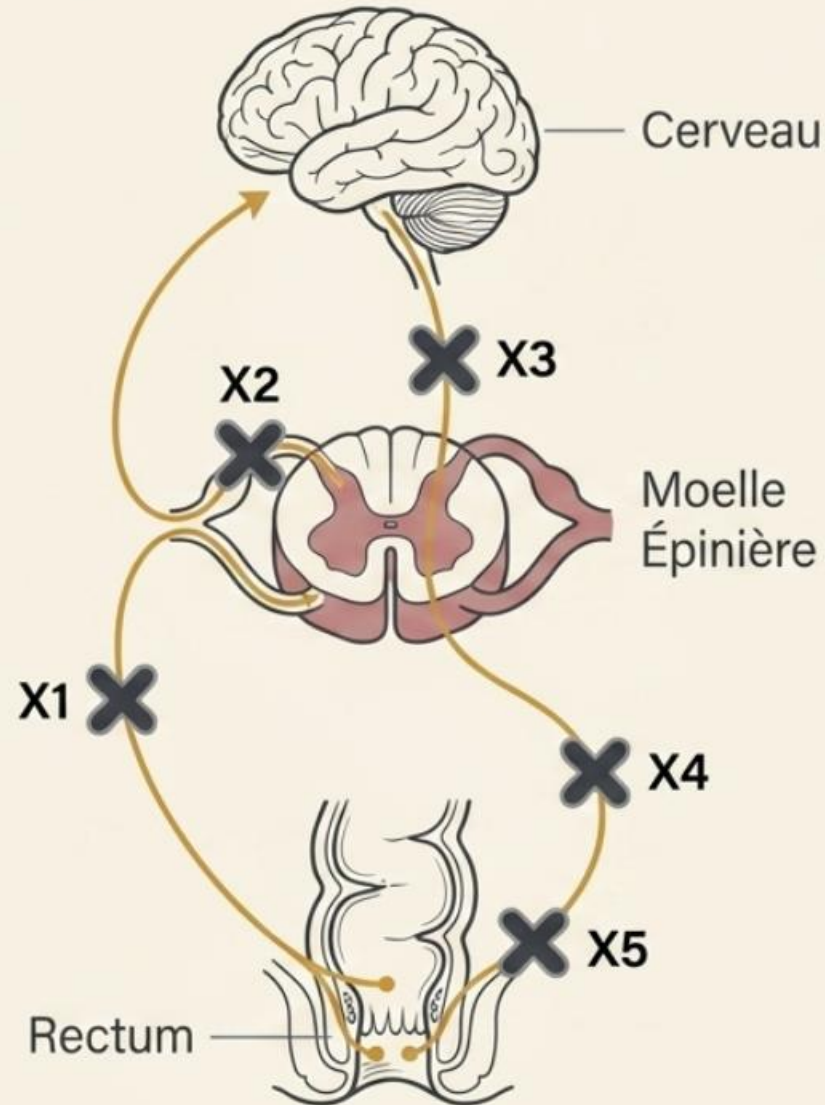


Aliments Favorisants / Fibres

Les fibres se gorgent d'eau : dattes, figes, artichauts, radis noir, mangue, papaye, pruneaux, raisin mûr, noix, épinard, céleri, endives, pain complet. (Nécessite de boire suffisamment).



L'Inhibition du Réflexe de Défécation



1. Temps : Personnes ignorant l'envie d'aller à la selle.

2. Âge : Perte de la sensibilité des récepteurs rectaux.

3. Mécanique : Insuffisance de la sangle abdominale ou ptose périnéale.

4. Traumatisme : Accouchement difficile avec déchirure du périnée.

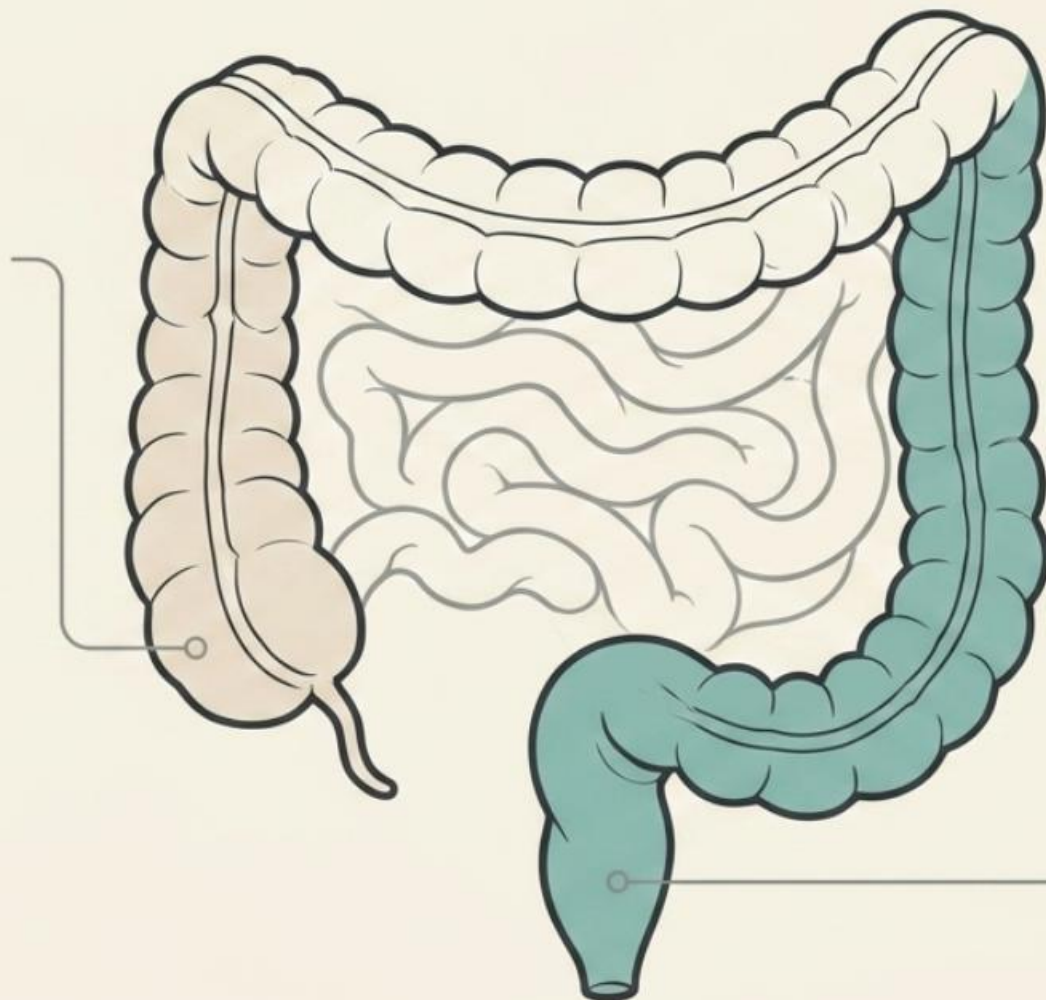
5. Chimique : Prise de médicaments (anxiolytiques, antidépresseurs, calmants) bloquant la transmission nerveuse.

Note : Iléus paralytique : Sidération totale du péristaltisme post-anesthésie/chirurgie.

Cartographie de la Constipation : Distale vs. Proximale

Constipation Proximale (Haute)

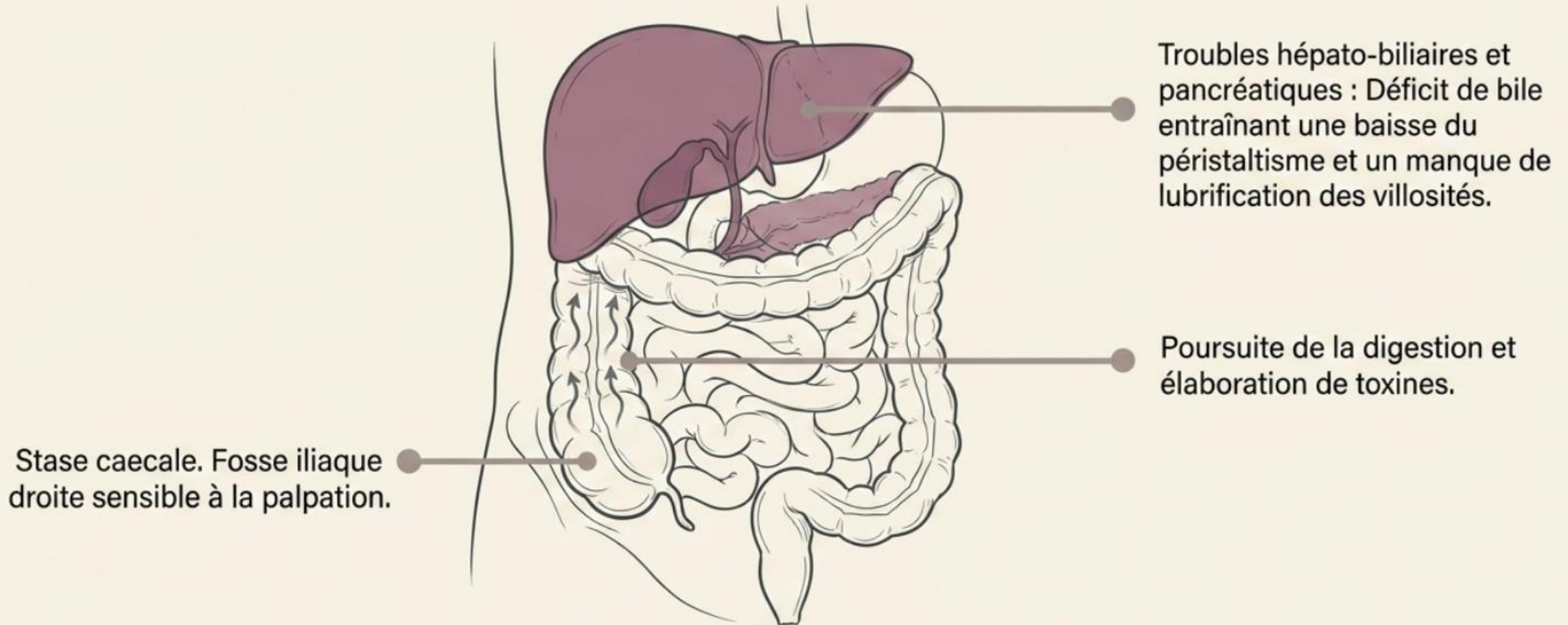
- **Localisation** : Stase dans le caecum.
- **Symptômes locaux** : Sensibilité de la fosse iliaque droite à la palpation.
- **Conséquences systémiques** : Élaboration de toxines (céphalées, dyspepsie, mauvaise haleine).



Constipation Distale (Basse)

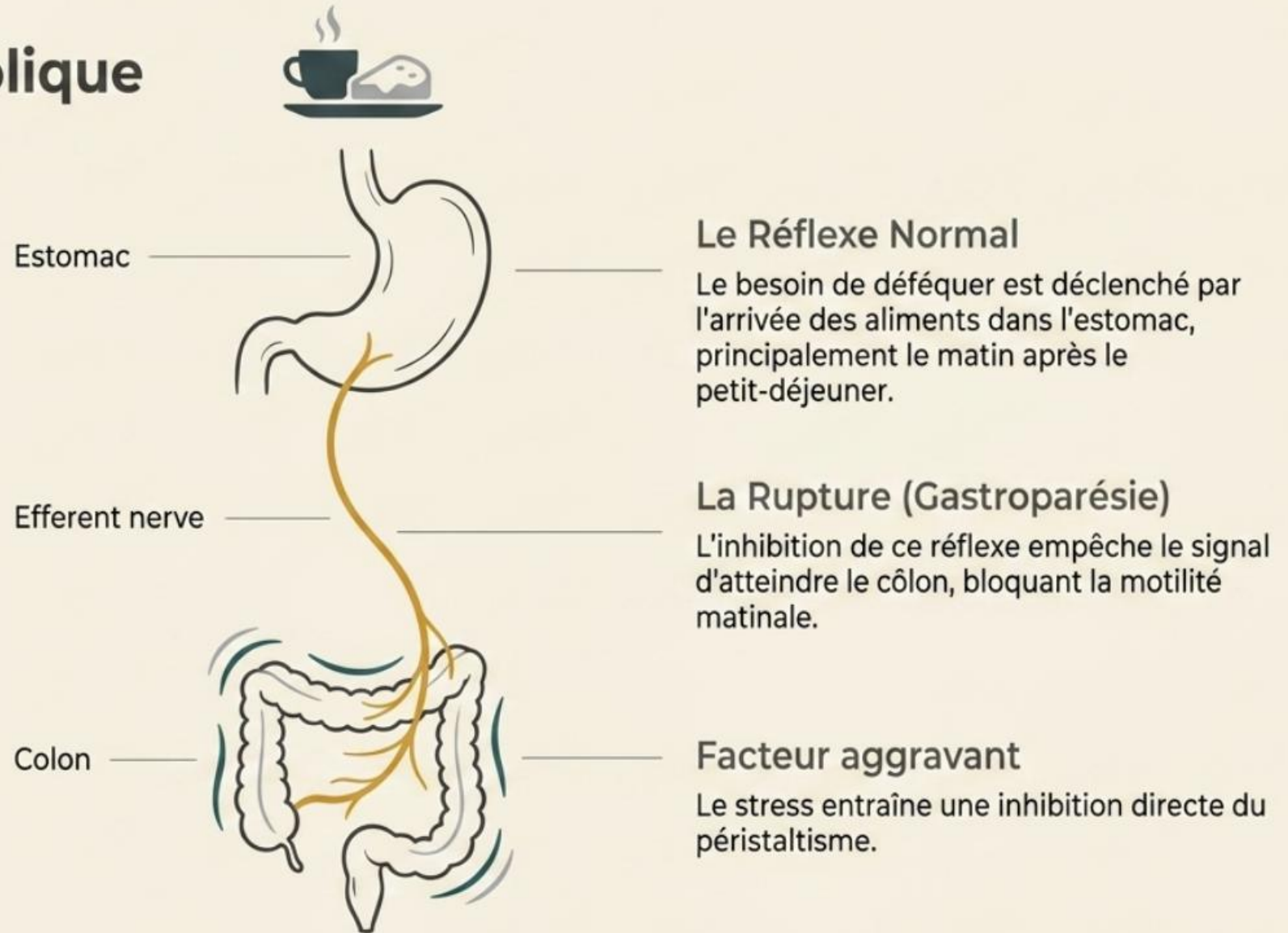
- **Localisation** : Stagnation dans l'ampoule rectale, sigmoïde ou côlon descendant.
- **Caractéristiques** : Souvent d'origine mécanique.
- **Tolérance** : Cliniquement mieux supportée par le patient.

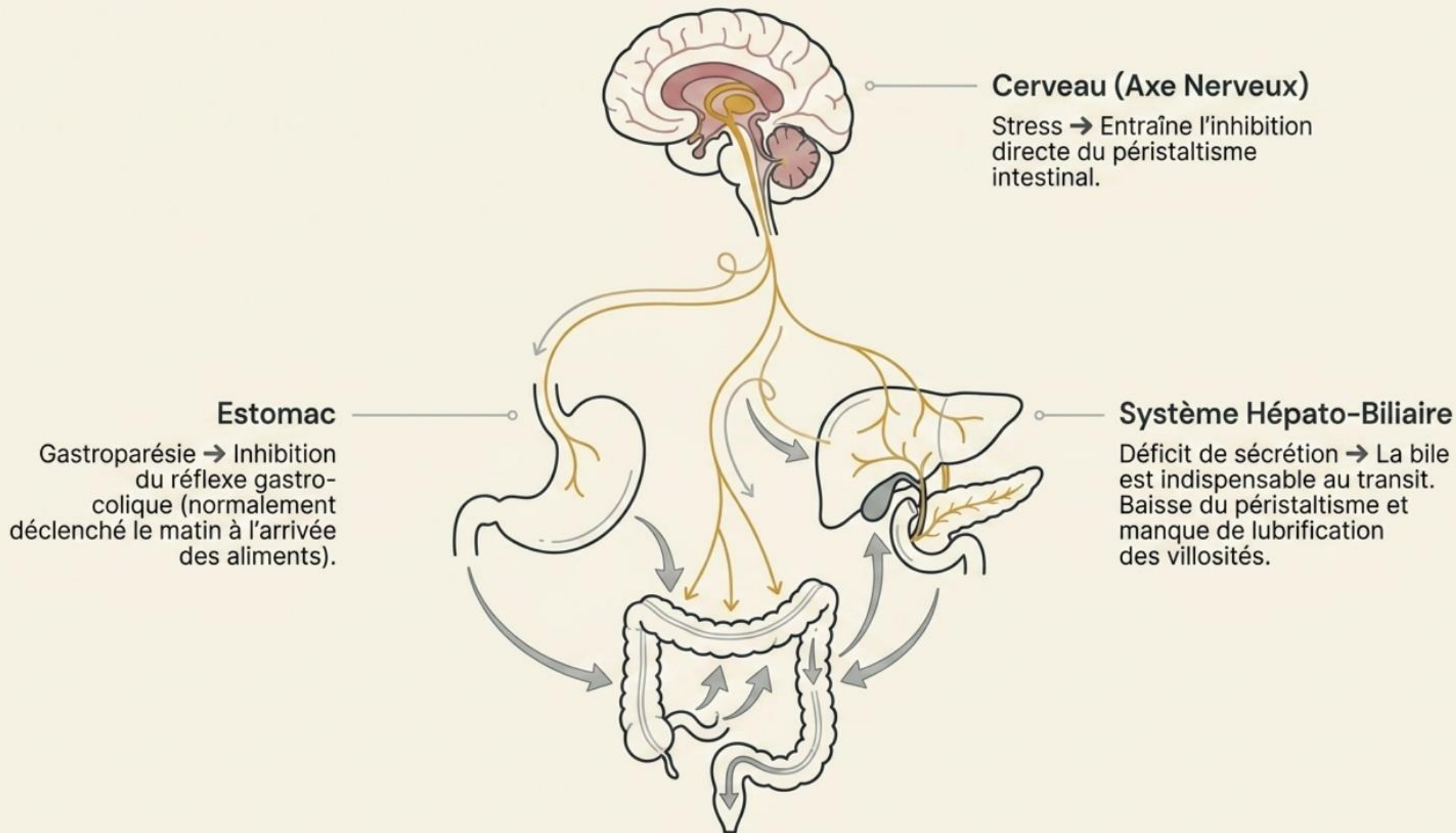
Constipations Proximales (Droites)



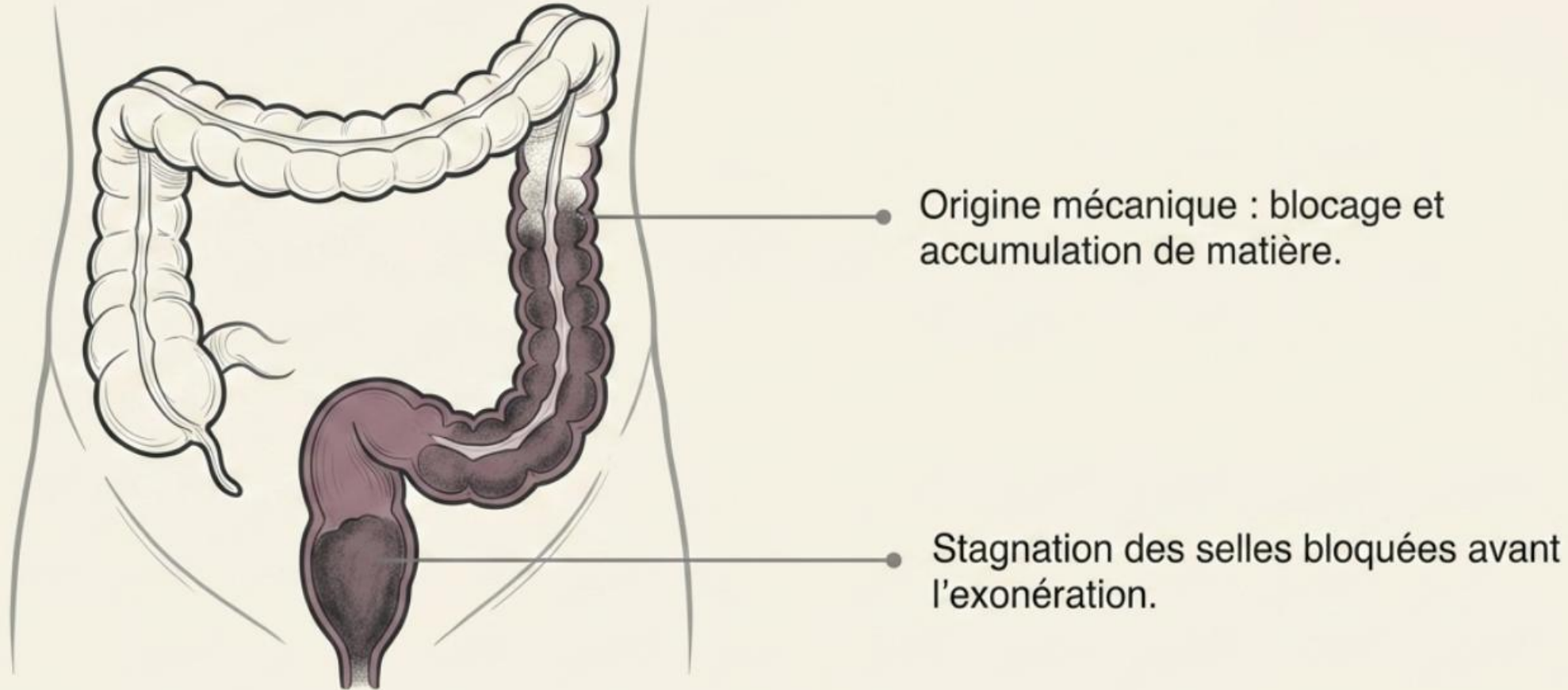
Conséquences systémiques : Céphalées, dyspepsie, mauvaise haleine

La Gastroparésie & Le Réflexe Gastro-Colique





Constipations Distales (Gauches)



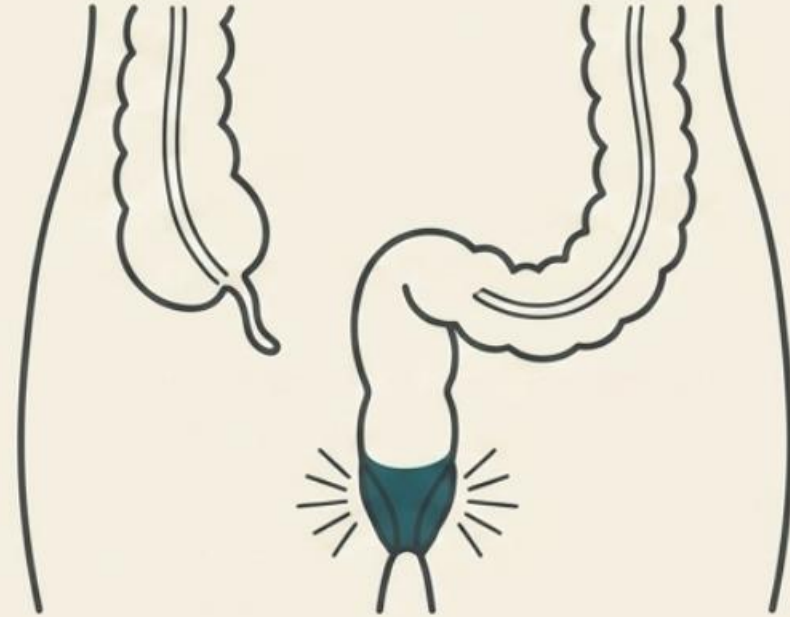
Note clinique : Ces constipations sont souvent mieux supportées par le patient que les constipations droites, car elles engendrent moins de toxines systémiques.

Focus Symptomatique : Épreinte vs Ténésme



Épreinte

Douleur spasmodique du sigmoïde ou du rectum. Provoque de fausses envies ou des envies impérieuses.



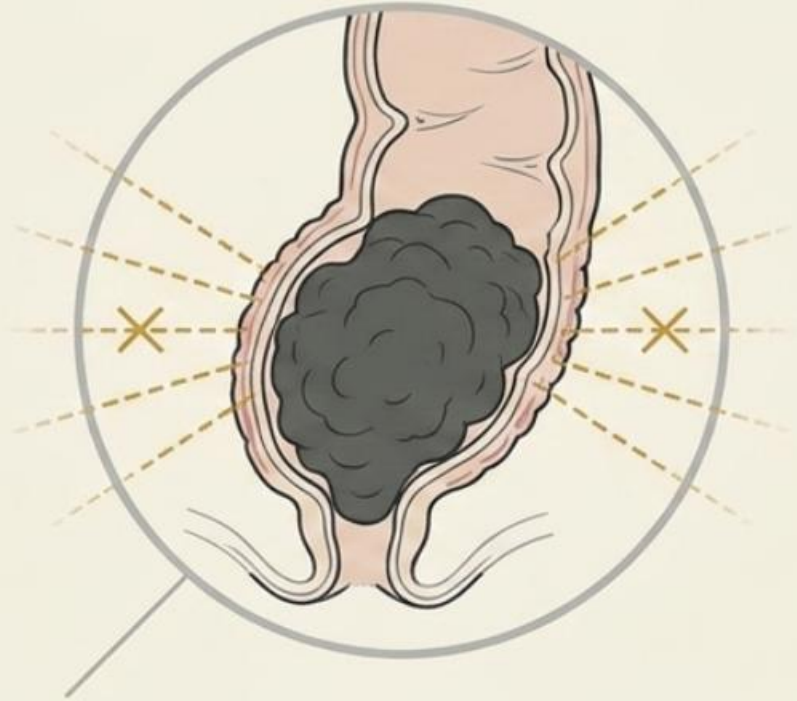
Ténésme

Sensation de tension localisée à l'anus. Provoque une envie d'aller à la selle.

Accompagné d'une gêne globale, d'un mal-être et de douleurs abdomino-pelviennes.

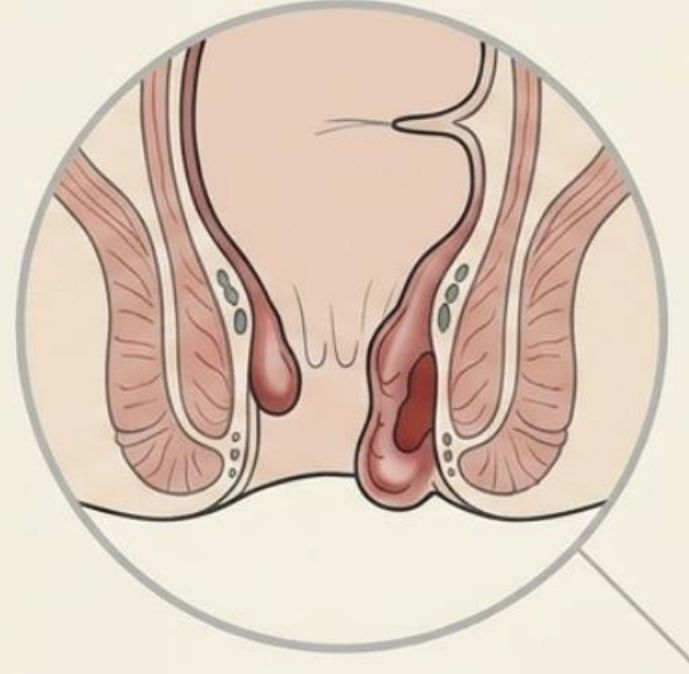
Complications Mécaniques :

Zoom Physiopathologique



Fécalome

Réabsorption d'eau créant une masse dure. La dilatation extrême du rectum empêche la stimulation des mécanorécepteurs. Le signal vers la moelle épinière est rompu : le réflexe de défécation est totalement inhibé.



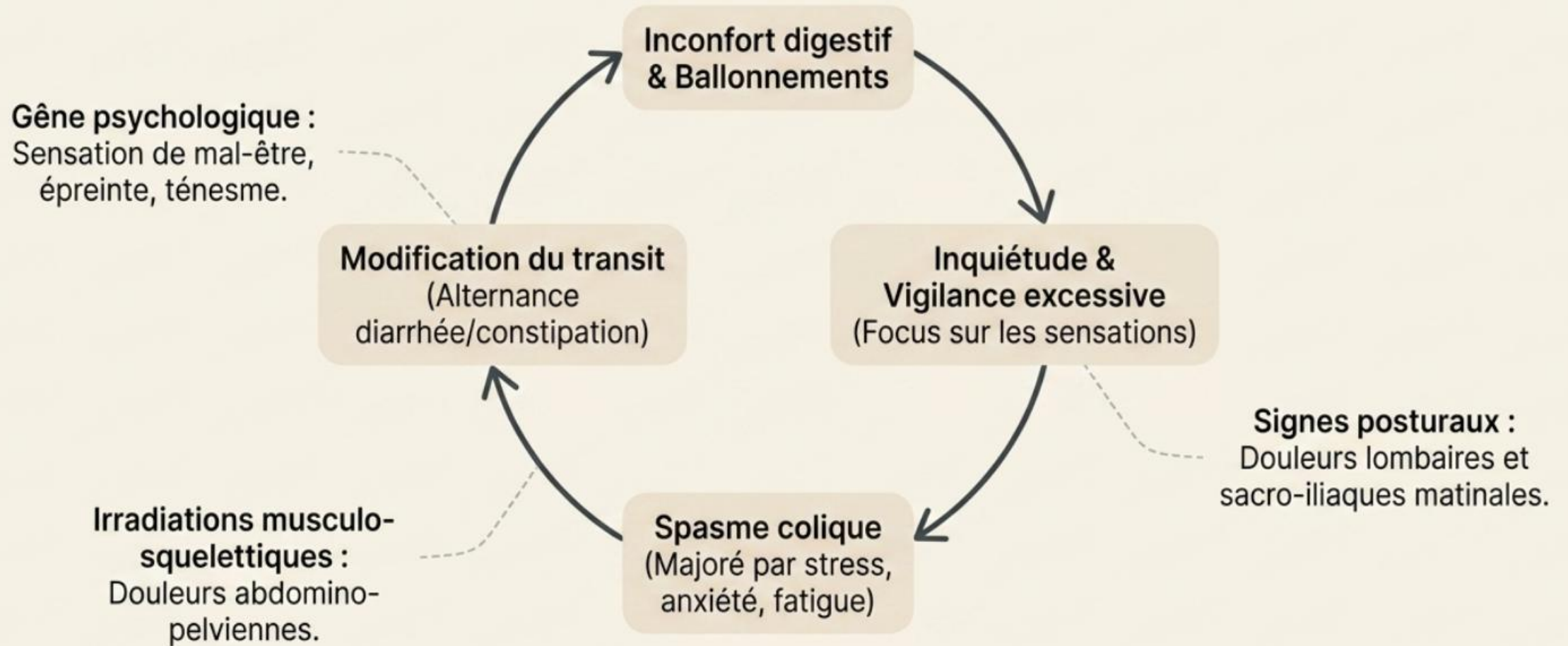
Thrombose Hémorroïdaire

La stagnation prolonge la tension de la paroi rectale, freinant le retour veineux. Apparition d'œdème et formation d'un caillot (crise hémorroïdaire), générant une douleur aiguë au frottement.

Matrice Diagnostique : Distinguer les Colopathies

	Colite	Syndrome de l'Intestin Irritable (SII)	Colopathie Spasmodique
Présence d'Inflammation	Lésion organique, tableau inflammatoire ou irritatif confirmé.	Aucune lésion organique évidente.	Altération locale transitoire (vasculaire/absorption) due au spasme, pas de lésion.
Mécanisme Principal	Pathologie structurelle.	Trouble de l'axe intestin-cerveau, hypersensibilité viscérale.	Hyper-réactivité motrice du côlon.
Déclencheurs Clés & Clinique	Symptômes continus liés à l'inflammation.	Douleurs récurrentes, ballonnements, modification chronique du transit.	Sensibilité aiguë au stress, au froid, aux repas spécifiques. Bruits intestinaux, alternance diarrhée-constipation.

Synthèse : Le Cercle Vicieux de la Colopathie Fonctionnelle



Le stress et la fatigue majorent les symptômes sans définir la personne.
L'objectif clinique est de rompre la boucle de l'hyper-vigilance.